

■ 回復期リハ／栄養と腸内細菌

たんぱく質の効果、 腸内の「酪酸菌」で差か

脳卒中で回復期に入院した高齢者156人 食事と便の菌から運動ADLの回復を解析

熊本リハビリテーション病院などのグループが、脳卒中の後に回復期リハビリテーション病院へ入院した65歳以上の156人（平均78.4歳、男性55.8%）を解析した。入院1週目の食事から「1000kcalあたりのたんぱく質量」を求め、入院14日以内に採った便の細菌を遺伝子配列で調べ、酪酸をつくるとされる菌の割合を出し

た。回復の指標はFIM運動項目の改善効率だ。たんぱく質の多さと酪酸産生菌の割合の「掛け合わせ」が、運動ADLの回復と有意に関連した(交互作用 $\beta=0.046$ 、95%CI 0.013~0.079)。菌の割合が高い人ほど、たんぱく質を多くとることと回復との結びつきが強い、という向きだ。FIMの他の指標でも似た傾向が出た

が、握力と骨格筋指数では見られなかった。1施設の登録データによる観察研究で、因果までは言えない。菌の働きは配列からの推定で、食物繊維や代謝物は測っていない。著者も前向き研究が必要だとしている。回復の差を考える手がかりの一つだ。



同じ食事でも、回復の伸びは人によって違う

出典 **Clinical Nutrition ESPEN** ↗

数字で見る

156人

解析した回復期の脳卒中患者

78.4歳

平均年齢

0.046

交互作用 β (95%CI 0.013~0.079)

■ 摂食嚥下／電気刺激

嚥下の筋を順番に刺激、 4チャンネルで改善大きく

飲み込みに関わる筋肉が働く順番をまねて順に刺激する4チャンネルの電気刺激(20人)と、従来の2チャンネル(20人)を、1回30分・週5回・6週間行った。嚥下造影で測る舌骨の前方・上方への動き、誤嚥の程度(PAS)、経口摂取の段階(FOIS)のいずれも4チャンネル群の改善が大きかった(舌骨の前方移動 $\eta^2p=0.327$ など)。

各群20人と小さく、評価は6週間の直後だけ。比



べた相手は別方式の電気刺激で、刺激なしとの比較ではない。刺激の「当て方」も効果を左右しうることを示す結果で、追試と長期の結果を待ちたい。

出典 **Journal of Oral Rehabilitation** ↗

■ PT・OT・ST／系統的レビュー

集団療法と個別療法、 効果に一貫した差なし

理学療法8件、言語聴覚療法2件、作業療法1件。脳卒中、パーキンソン病、膝の痛み、尿失禁などが含まれる。比べた76の評価項目のうち67(88%)で差がなく、集団が上回ったのは5、個別が上回ったのは4だった。

ただし11件のうち8件は偏りのリスクが高く、証拠の確実性は全項目で「低い」か「非常に低い」。統合解析はできず、



費用を比べた研究もない。著者も「差が出ないことは同等の証明にはならない」と注意している。

出典 **Frontiers in Rehabilitation Sciences** ↗

短 信

〈回復期〉入院時の3指標を合成、退院時FIMを予測

福岡の回復期整形の高齢者158人。歩行速度・TUG・BBSの合成点が退院時のFIM運動を単独指標より良く予測

出典 **Am J Phys Med Rehabil** ↗

〈転倒〉大腿骨骨折の術後1年、約3割が転倒

広島の107人を後ろ向きに解析。転倒した34人は細胞外水分比が高く骨格筋指数が低かった(単施設)

出典 **理学療法の臨床と研究** ↗

〈運動療法〉ストレッチ、1日30分と週3回3分で差なし

タイのサルコペニア疑いの高齢者68人のRCT。可動域の伸びに差は検出されず、筋力は遠心性運動で改善

出典 **Eur J Appl Physiol** ↗

〈制度〉厚労白書、訪問リハの技術導入は28%

令和8年版厚生労働白書が公表。ICT・AI・ロボット等の導入率は訪問リハ28%、通所リハ53%と紹介 出典 **POST** ↗

〈フレイル〉フレイル予測の血液指標に3候補

国立長寿医療研究センターが168人を解析。骨格筋指数・アペリン・GDF15が将来の筋力低下の目安になる可能性

出典 **GemMed** ↗

〈医療AI〉AI遠隔運動療法、続けた人ほど痛み軽く

米国の慢性腰頸部痛の約2万人を事後解析。曜日を決めて続けた人ほど最終の痛みが低いが、効果は小さい

出典 **J Pain Res** ↗

〈失語症〉失語症の自己管理アプリ、設計原則5つ

失語症の人・家族・専門職計31人の声から整理。病院と地域の間の「大きな断絶」を埋める仕組みを求めた

出典 **Disabil Rehabil** ↗

〈めまい〉末梢性めまい、理学療法への紹介は2割

米国の約2万人の電子カルテ解析。紹介率21.7%で、救急からの紹介は耳鼻科の約5分の1にとどまった

出典 **Otolaryngol Head Neck Surg** ↗